

VERA LUCIA MARTINS AMARAL	
HD:	APNEIA DO SONO
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	
30/06 adaptação de CPAP — Jua Modo autôn.	
07/07 - P = 12.9 IAH = 10.5 m. de uso: 7h40 Jua	
21/07 P = 13 (m. de P 90% = 8,05 cmH ₂ O) 21 IAH = 5,1 ID0 (7.6/l)	
18/08 P = 9.3 Ajusto a mare. e teste 21 IAH = 5.8 a mare. EASON. m. de uso: 19.8 Jua	
20/10 P = 9.3 21 IAH = 4.8 m. de uso: 18h20 Jua Obs direto a EASON 2. B.	
22/12 P = 9.8 21 m. de uso: 18h20' IAH = 4.6 Jua	
14/06/22 P = 9.9 IAH = 6,9 m. de uso: 8h20' Jua	
16/08/22 P = 9.9 IAH = 4.8/l m. de uso: 7h Jua	

15/09
22 P: 9,5 cmH₂O
IAH = 6/2

m. de uso: 6h42'

Relata que estava q 12^{to} na marinha - fcu

21/11
22 P: 9,0 cmH₂O

IAH = 5,9 e/h

m. de uso: 6h30'

Bem adaptada

fua.

24/02
2023 P: 6 cmH₂O.

IAH = 7

média uso: 6 horas

Ajusto P: 5 - 7 cmH₂O

trocou a máscara da prima
relata estar com odo qdo acorda
nã dorme d a máscara note toda
cirurgia psicológica
máscara orofaral Yuwell

24/03
2023

P: 7 cmH₂O (média 5,6) ??

IAH = 7 (~ 11,5)

fuga = 11,5 l/min

média uso = 7h30'

- relata que acorda com odo
- cabeça pesada
- Dr Alberto passou medicamento
p/ o sono
prima.

4 P: 6 - 9 cmH₂O

tempo 10 min EPR = 1

(com máscara orofaral 4 Prener)

24/04
23

P: 9 cmH₂O

IAH = 5,4 e/h

m. de uso = 7h44'

fuga = 6,1 l/min

- melhora do cansaço e da afasia
(relata que é a posição do fixador).

(3 meses)

fua cláudia.

26/07
2023

P: 7,1 cmH₂O P90: 9 cmH₂O

IAH = 5,5 e/h

m de uso = 6h20 min

fuga = 26,8 l/min.

não usou → gupada < passou
17B + med bronquite
hoje vai usar
ajusto másc (cf escape) Silence

23/08
2023

P: 7 cmH₂O

P15: 8,8 cmH₂O.

IAH = 5,1 e/h.

m de uso = 6h53 min.

fuga = 34 l/min

- pequeno másc suave (M)

- másc orofaral cf mto escape mesmo

20/01/23

P: 7 cmH₂O P90: 8,8 cmH₂O

IAH = 5,5 e/h

m de uso = 7 horas

fuga = 15 l/min

→ distorção face → ajustamos
P. 6 a 9 cmH₂O.
repetido
→ mto de obstrução
diminuída

VERA LUCIA MOU		NS 2200
IDADE: 46	PESS	
SINTOMAS:		

06/12 P=6,6 cmHg P90: 8,38 cmHg Jato 6-9 cmHg
 2073 IAH = 5,2 elh
 m. de uso = 6 h 22' fazendo tto cl olonino p/ xunirle
 fugo = 15 l/min.
 09/12 P=8,8
 24 IAH = 5,7 elv
 m. de uso: 7h-
 boca seca, acordando cansado. sua.



clínica

DR. ALBERTO REMESAR

TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO

PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

Certificação em Medicina do Sono

Sociedade Brasileira de Sono

Mestre em Psiquiatria pela UNFAP

Doutor em Ciências pela UNIFESP

CRM-SP 69730

DRa. ELITÂNIA MARINHO PONTES

Medicina do Sono

Crianças e Adolescentes

CRM-SP 62858

Prezada Dra. Ana Cláudia,

Solicito o aluguel / venda do CPAP para a Sra. Vera Lucia Martins Amaral. Ela fez a polissonografia e confirmou a síndrome da apnéia obstrutiva do sono.

Atenciosamente,

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM 69730

SJC, 29/6/21

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSICUATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69.730

DRG. ELITÂNIA MARIANO
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Vera Lucia Martins Amaral

EXAME nº: 4879

SOLICITADO POR: Dr. Glauco Tupinambá Fernandes de Sá

DATA: 20/05/2021

IDADE: 71 anos

Comentários:

Exame iniciado às 20h57min e concluído às 06h23min. A latência para o sono foi de 21 minutos e a latência para o estágio REM, de 131 minutos. O tempo total de sono foi de 484 minutos (08h04min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 86%. A distribuição do sono mostrou 27,9% de estágio 1, 49,2% de estágio 2, 2,8% de estágio 3 e 20,1% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 58 minutos em vigília, ocorreram 357 microdespertares (índice: 44,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 6,1/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 59,6/hora, sendo 8,9 apneia/hora e 50,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 59,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 90% e a mínima de 56%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (59,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (59,6/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, arritmia cardíaca e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 71 bpm.

O ronco foi intermitente e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 21 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (131 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono normal (86%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 44,3/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (27,9%; normal: 8-10%) e a redução do estágio 3 (2,8%; normal: 10-12%). As porcentagens dos estágios 2 (49,2%; normal: 45-55%) e REM (20,1%; normal: 20%) permaneceram nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (6,1/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade. Observei também movimentos de pernas após despertares.

Escala de Sonolência de Epworth: 15 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

18/250

NTUAL